

04. MISE EN PLACE DE L'ŒIL

DURÉE : 08:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la mise en place de l'œil dans le cadre de l'embryologie biodynamique et de l'ostéopathie. Vous apprendrez comment l'interaction entre l'endoderme et le mésoderme, ainsi que le rôle primordial de la notochorde et du tube neural, participent à la formation de structures essentielles comme l'œil. Les mouvements de perméation et d'infusion, ainsi que la notion de polarité, sont des concepts clés qui sous-tendent le développement embryonnaire. De plus, il sera abordé comment des techniques de rééquilibrage, en réponse aux whiplash émotionnels ou physiques, peuvent restaurer les mouvements nécessaires au développement optimal de l'œil, le liant ainsi à des événements tels que le premier battement cardiaque.

MISE EN PLACE DE L'ŒIL

L'**endoderme** est un épithélium, tandis que le **mésoderme** est un tissu conjonctif. Il est essentiel de comprendre l'équilibre entre ces deux grands types de tissus : un tissu d'intérieur et un tissu d'extérieur. Par exemple, l'épithélium digestif, bien qu'il soit à l'intérieur, agit comme un tissu de limite.

Le précurseur de la **gouttière neurale** et de la **plaque neurale** est la **notochorde**. Ce processus d'évagination dans un axe longitudinal est en rapport avec la **ligne primitive**, qui constitue l'axe primitif du corps. Cet axe est crucial car il organise les cellules en fonction de leur espace, de leur temps et de leur devenir.

Au 18ème jour, la plaque neurale se développe, et la troisième cavité, celle du **cellome externe**, apparaît. Ce changement de polarité et la réorganisation de l'axe créent la ligne primitive par un champ d'aspiration de la zone caudale, qui « aspire » l'information. Ce phénomène est accompagné de mouvements appelés **perméation** et **infusion**.

Le mouvement de perméation, un grand mouvement métabolique, se produit autour de l'embryon, faisant avancer la **cavité amniotique**. On distingue ainsi la cavité amniotique, la cavité viteline et un tissu appelé **épiblaste**, qui donnera le futur système nerveux, tandis que le tissu en dessous formera le futur système digestif.

Ce mouvement provoque un changement de forme de la notochorde, qui prend une forme en S. Cette croissance différentielle est liée à la polarité. L'axe primitif organise le tissu épithélial, qui réagit par des phénomènes d'induction et d'inhibition en relation avec la notochorde.

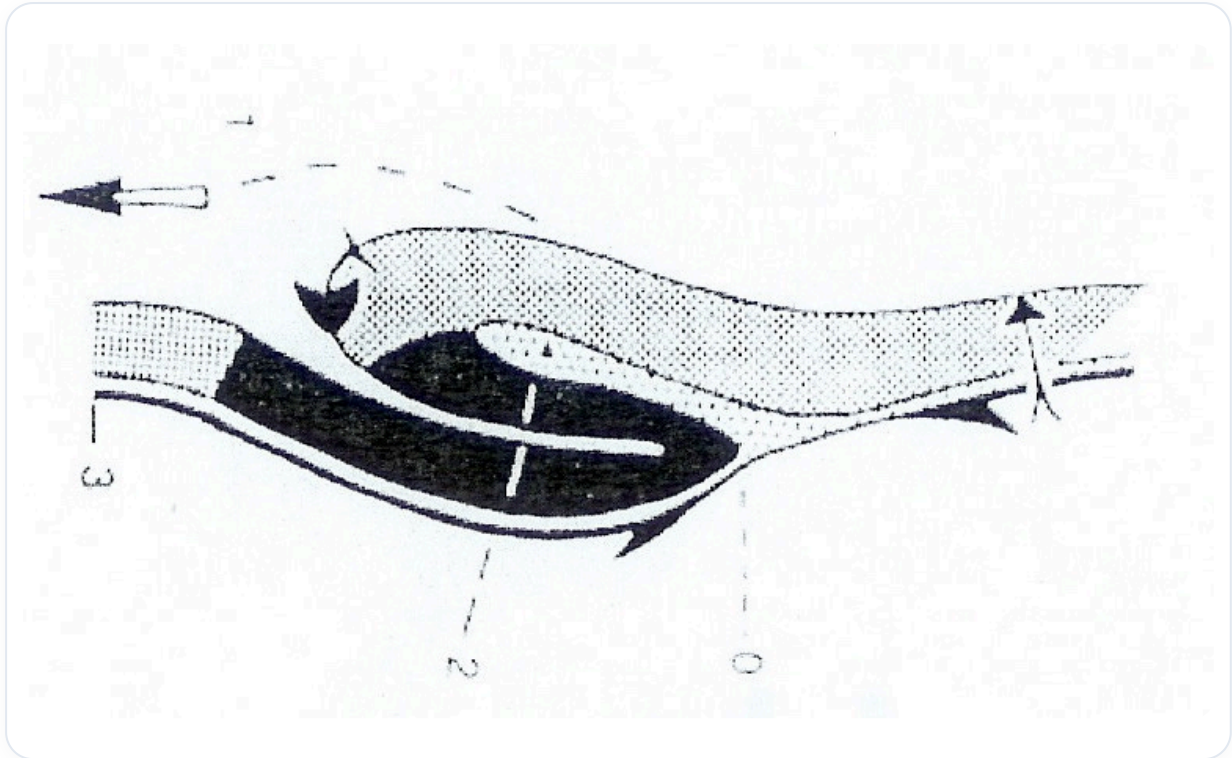


FIG. — Croissance différentielle

La plaque neurale évolue pour devenir une **gouttière neurale**, qui enferme du liquide céphalo-rachidien, ou plutôt du liquide amniotique primitif.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural

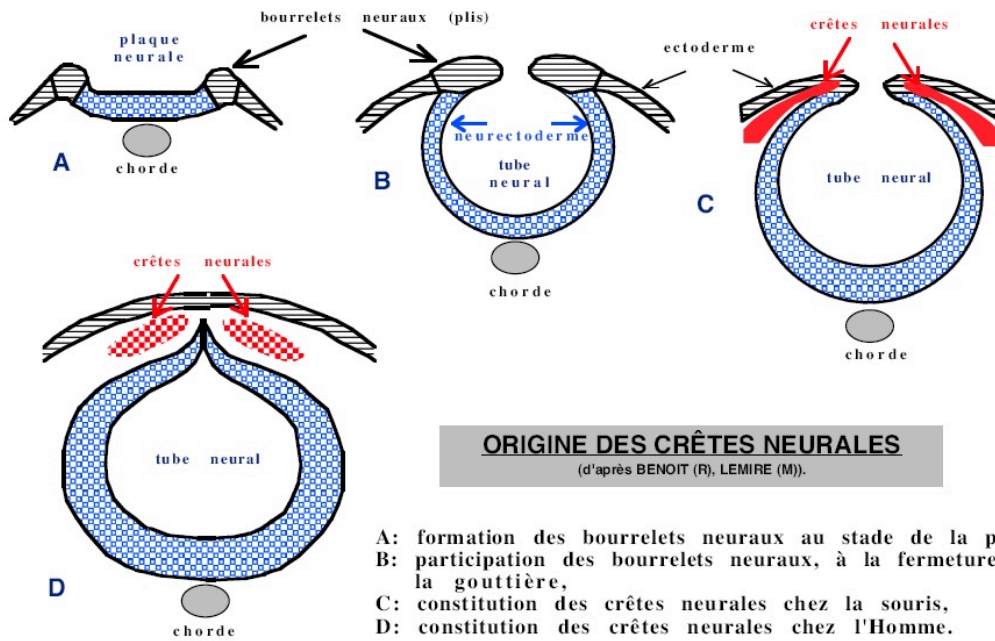


FIG. — Liquide amniotique primitif

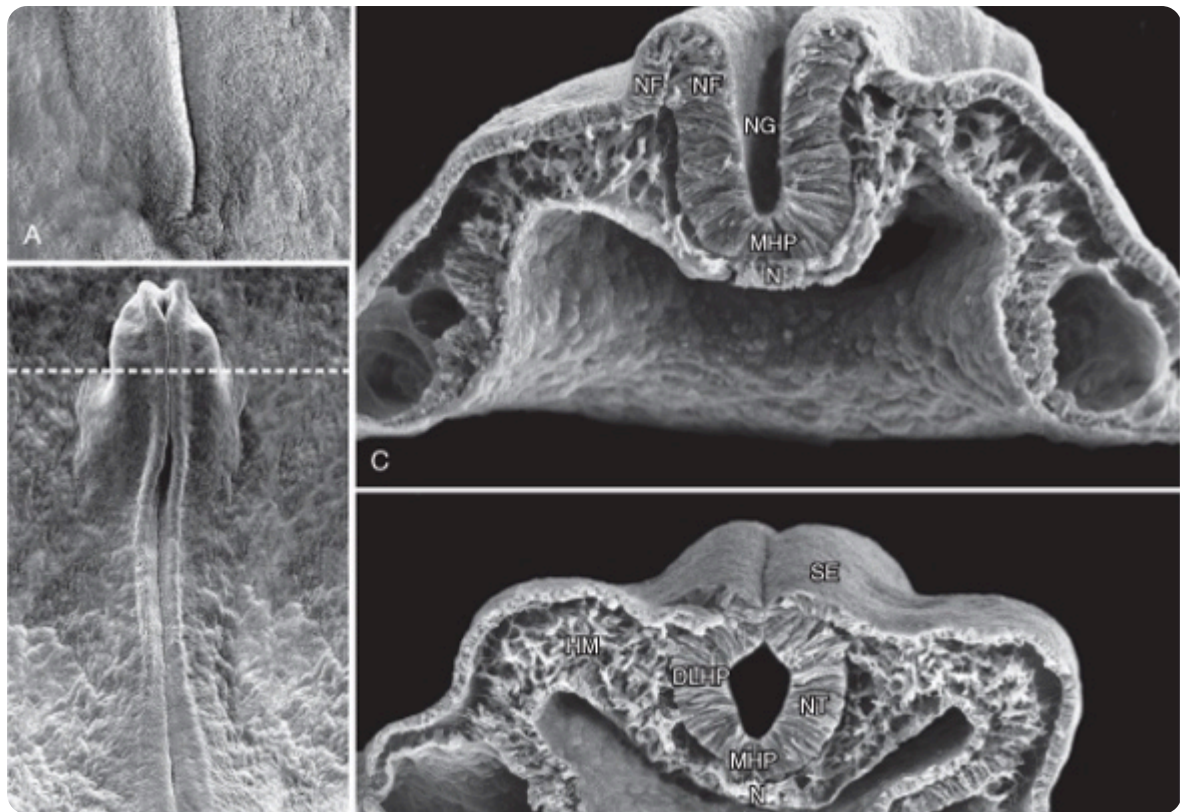
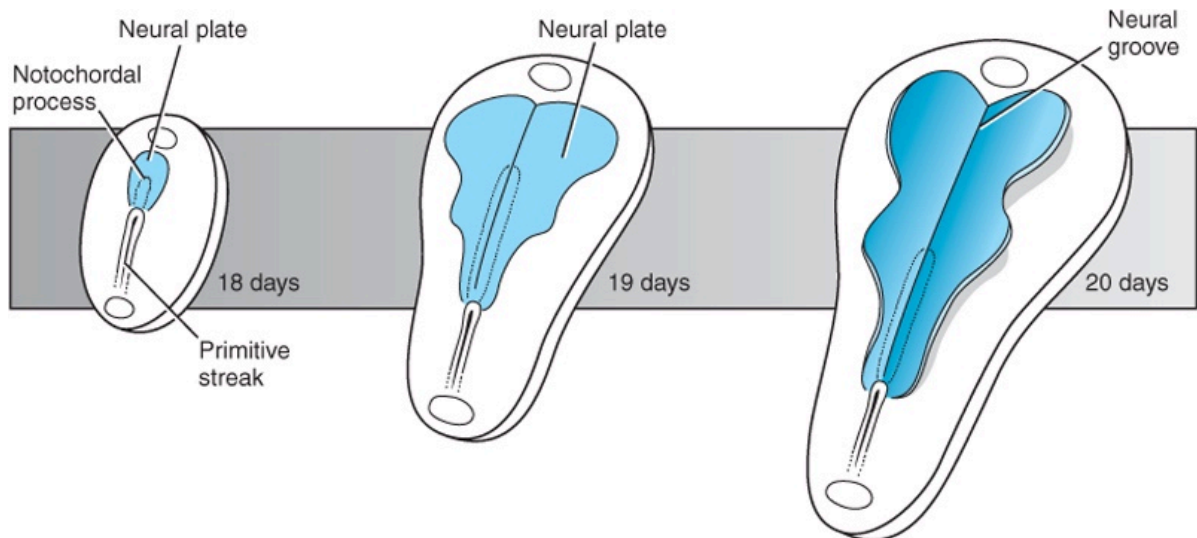


FIG. — Formation de la gouttière neurale



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Transformation de la plaque neurale en gouttière neurale

La fermeture de cette gouttière forme un **tube neural**. Les **crêtes neurales**, considérées comme un quatrième tissu embryonnaire, jouent un rôle crucial dans le développement de l'œil.

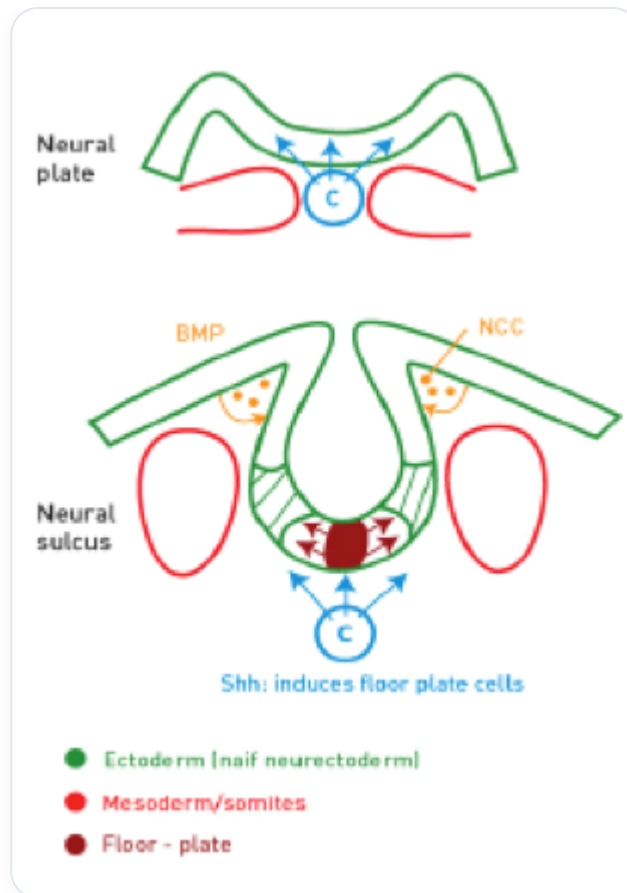


FIG. — Fermeture pour former le tube neural et la formation des crêtes neurales

La notochorde est essentielle pour la mise en place de l'œil. Sans une notochorde équilibrée, il est impossible d'avoir un œil stable. De même, un sacrum libre est nécessaire pour garantir la stabilité du cerveau. Il est donc fondamental de rééquilibrer le sacrum pour assurer une bonne verticalité.

L'embryon présente la cavité amniotique, la cavité viteline et le disque didermique, qui s'organisent autour de l'axe notocordal et du tube neural. La formation de ce tube neural implique la fermeture de la cavité amniotique et de la cavité viteline.

Au fur et à mesure que l'axe longitudinal de l'embryon se développe, l'ébauche du cerveau se forme et se ferme au centre de l'embryon, laissant un vestige en haut. C'est dans cet espace que se développe la **placode cristalline**, qui formera l'œil.

Avant la fermeture du tube neural, un phénomène d'induction se produit pour former la notochorde, qui est à la base du développement cortical. De ce développement émergera l'œil, qui est une expansion d'un système ventriculaire rempli de liquide céphalorachidien. L'œil peut être considéré comme une sphère liquidienne, un filtre subtil pour les photons et un équilibrage de l'espace environnant.

Il est possible de rééquilibrer l'œil en travaillant sur une zone spécifique, souvent affectée par des **whiplash**. Ces whiplash peuvent être d'origine émotionnelle ou physique. Traiter un whiplash implique de restaurer les mouvements de **séphalisation**, **cardialisation**, **diaphragmatisation** et **hépatisation**, qui sont essentiels pour le développement embryonnaire.

L'émergence de l'œil commence avec le premier battement cardiaque, vers le 22ème jour. La première transformation cellulaire épiblastique se produit en synchronisation avec ces battements cardiaques primitifs, établissant une correspondance significative entre le développement de l'œil et l'activité cardiaque.